

CAPÍTULO 11.13

Nefritis Intersticial

PERFIL EUNACOM 1.06.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El diagnóstico diferencial de las **glomerulonefritis (GN)** es un pilar fundamental en la nefrología del EUNACOM. A menudo, la clave no está solo en el sedimento urinario, sino en la historia clínica, la edad del paciente, el tiempo de latencia tras una infección y los niveles de complemento.

A continuación, analizamos seis escenarios clínicos típicos que permiten diferenciar las patologías glomerulares más preguntadas.

1. Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger)

Este es el caso del adolescente (13 años) que presenta **hematuria macroscópica** de forma **simultánea** a un cuadro de vía respiratoria superior (resfrió o faringitis).

- **Clave diagnóstica:** Hematuria "sinfaringítica" (ocurre al mismo tiempo que la infección).
- **Sedimento:** Hematuria dismórfica (confirma origen glomerular).
- **Función renal:** Suele ser normal inicialmente (Creatinina 0.8 mg/dL).
- **Examen físico:** Generalmente normal, sin edema ni hipertensión marcada.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si la hematuria ocurre **1 a 2 días** después de la infección, piensa en **IgA**. Si ocurre **1 a 3 semanas** después, piensa en **Post-estreptocócica**.

2. Granulomatosis con Poliangeítis (Wegener)

Se presenta en adultos jóvenes o medianos (ej. 27 años) con un compromiso sistémico importante y afectación de la vía aérea.

- **Clave diagnóstica:** Antecedente de **sinusitis crónica**, rinitis persistente o nódulos pulmonares, sumado a una caída abrupta de la función renal.
- **Presentación:** Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP). El paciente presenta oliguria y creatinina muy elevada (ej. 5.5 mg/dL).
- **Laboratorio:** Suele asociarse a **ANCA-c** (anti-PR3) positivo.
- **Clínica:** Síndrome nefrítico completo (hipertensión, edema, hematuria).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La presencia de síntomas en la vía aérea superior (sinusitis, otitis, epistaxis) junto con falla renal es el "clásico" para sospechar Granulomatosis de Wegener.

3. Nefritis Lúpica

Mujer joven (20 años) con síntomas constitucionales y compromiso multiorgánico.

- **Clave diagnóstica:** Artralgias, febrícula y **sedimento urinario activo** (hematuria dismórfica y **cilindros eritrocitarios**).
- **Complemento:** Se observa **hipocomplementemia** (C3 y C4 disminuidos).
- **Función renal:** Puede presentar elevación de creatinina (ej. 2.1 mg/dL), sugiriendo una GN progresiva.

NOTA CLÍNICA

Los **cilindros eritrocitarios** son patognomónicos de sangrado glomerular activo y suelen indicar una inflamación severa del glomérulo, muy frecuente en el **Lupus Eritematoso Sistémico**.

4. Glomerulonefritis Post-estreptocócica (GNPS)

Típica de la edad pediátrica (ej. 7 años) tras una infección por *Streptococcus pyogenes*.

- **Clave diagnóstica:** Periodo de latencia de **2 semanas** tras una amigdalitis (o 3-4 semanas tras una infección cutánea/impétigo).
- **Clínica:** **Síndrome Nefrítico** clásico (Edema, Hipertensión arterial y Hematuria).
- **Laboratorio:** **Hipocomplementemia transitoria** (C3 bajo que se normaliza en 6-8 semanas).
- **Manejo:** Soporte (control de presión y edema). No requiere corticoides de entrada.

TABLA 11.13.1: CARACTERÍSTICA VS NEFROPATÍA POR IGA

CARACTERÍSTICA	NEFROPATÍA POR IGA	GLOMERULONEFRITIS POST-ESTREPTOCÓCICA
Edad típica	Adolescente / Adulto joven	Escolar (niño)
Latencia	< 3 días (simultánea)	1 - 3 semanas
Complemento	Normal	Bajo (C3)
Recurrencia	Frecuente	Excepcional

5. Poliangeítis Microscópica (PAM)

Se sospecha en pacientes mayores (ej. 65 años) con cuadros de vasculitis de vaso pequeño.

- **Clave diagnóstica:** Adulto mayor con síntomas sistémicos (tos, artralgias), **GN rápidamente progresiva** (creatinina 6.0 mg/dL) y crisis hipertensiva.
- **Diferencia con Wegener:** A diferencia de la granulomatosis con poliangeítis, la PAM **no suele afectar la vía aérea superior** (no hay sinusitis).
- **Laboratorio:** Asociada frecuentemente a **ANCA-p** (anti-MPO).

EUNACOM CRITERIOS

En el adulto mayor, una falla renal aguda con sedimento nefrítico debe hacernos sospechar siempre una vasculitis pauciinmune (ANCA positiva).

6. Glomerulonefritis Membranoproliferativa (Mesangiocapilar)

Un cuadro complejo que a menudo "engaña" porque comparte características de otras GN.

- **Clave diagnóstica:** Paciente joven con cuadro de GN que presenta **orinas espumosas** (indicativo de proteinuria en rango nefrótico). Es un cuadro mixto (Síndrome Nefrítico + Síndrome Nefrótico).
- **Presentación:** Puede simular una enfermedad de Berger (hematuria recurrente con resfrios), pero la diferencia clave es el **complemento bajo**.
- **Laboratorio:** Hipocomplementemia persistente.
- **Confirmación:** Requiere biopsia renal necesariamente para diferenciarla de la IgA.

Resumen de Hallazgos en Glomerulonefritis

TABLA 11.13.2: PATOLOGÍA VS EDAD			
PATOLOGÍA	EDAD	COMPLEMENTO	HALLAZGO CLAVE
IgA (Berger)	Joven	Normal	Hematuria sinfaringítica
Post-estreptocócica	Niño	Bajo	Latencia 2 semanas post-faringitis
Lupus (clase IV)	Mujer joven	Bajo	Artralgias + Cilindros hemáticos
Wegener (GPA)	Adulto	Normal	Sinusitis + C-ANCA
PAM	Anciano	Normal	GNRP + P-ANCA
Membranoproliferativa	Joven	Bajo	Nefrítico + Nefrótico

Algoritmo de Enfrentamiento Inicial

- **Confirmar Glomerulonefritis:** Presencia de hematuria dismórfica (>20-50%) y/o cilindros eritrocitarios en el sedimento.
- **Evaluar Función Renal:** Si la creatinina sube rápidamente (dobla su valor en días/semanas), estamos ante una **GN Rápidamente Progresiva**. Requiere derivación urgente y probable biopsia.
- **Pedir Complemento (C3 y C4):**
 - - Si está **bajo**: Pensar en Post-estreptocócica, Lupus, Membranoproliferativa o Crioglobulinemia.
 - - Si está **normal**: Pensar en IgA o Vasculitis ANCA (Wegener/PAM).
- **Evaluar síntomas extra-renales:** Pulmón (hemoptisis), vía aérea superior (sinusitis), piel (púrpura), articulaciones (artritis).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Toda sospecha de glomerulonefritis con deterioro de la función renal debe ser derivada de forma **urgente** a Nefrología para estudio histológico (biopsia), ya que el tratamiento oportuno con inmunosupresión puede salvar la función renal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente en tratamiento con amoxicilina por neumonía presenta fiebre, rash maculopapular generalizado y eosinofilia en hemograma. La creatinina subió de 1.0 a 2.8 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Nefritis Intersticial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Nefritis intersticial: inflamación del intersticio y túbulos, NO del glomérulo. Sin hematuria dismórfica.
- Causa más frecuente: fármacos (AINEs, betalactámicos). También infecciones y autoinmunes (Sjögren, sarcoidosis).
- Tríada clínica: fiebre + rash + eosinofilia (síndrome DRESS) + eosinófilos en orina.
- Toda reacción cutánea con eosinofilia en contexto de fármaco debe alarmar por posible nefritis intersticial.
- Síndrome óculo-renal idiopático: nefritis intersticial + uveítis (autoinmune).
- Diagnóstico definitivo: biopsia renal.
- El tratamiento (suspender fármaco + corticoides) se inicia ante la SOSPECHA CLÍNICA, antes de la biopsia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEFRITIS INTERSTICIAL)

PREGUNTA 1

Paciente en tratamiento con amoxicilina por neumonía presenta fiebre, rash maculopapular generalizado y eosinofilia en hemograma. La creatinina subió de 1.0 a 2.8 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- ☐ A) Esperar resultado de biopsia renal antes de actuar
- ☐ B) Suspender amoxicilina e iniciar corticoides de inmediato
- ☐ C) Cambiar a otro betalactámico
- ☐ D) Solicitar sedimento urinario buscando hematuria dismórfica
- ☐ E) Aumentar hidratación para proteger la función renal

PREGUNTA 2

Paciente con síndrome de Sjögren conocido presenta falla renal progresiva con proteinuria leve y leucocituria. Sedimento sin hematuria dismórfica. ¿Cuál es la complicación renal más probable?

- ☐ A) Glomerulonefritis por complejos inmunes
- ☐ B) Nefritis intersticial (túbulo-intersticial)
- ☐ C) Necrosis tubular aguda
- ☐ D) Síndrome nefrótico por cambios mínimos
- ☐ E) IRA prerenal

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes hallazgos diferencia la nefritis intersticial de la glomerulonefritis?

- ☐ A) Presencia de proteinuria
- ☐ B) Presencia de insuficiencia renal
- ☐ C) Ausencia de hematuria dismórfica en la nefritis intersticial
- ☐ D) Presencia de leucocituria
- ☐ E) Necesidad de biopsia renal

RESUMEN: NEFRITIS INTERSTICIAL

La nefritis intersticial (o nefritis túbulo-intersticial) es la inflamación del intersticio y túbulos renales, no del glomérulo. No hay hematuria dismórfica. La causa más frecuente son fármacos (AINEs, betalactámicos), seguida de infecciones y enfermedades autoinmunes (síndrome de Sjögren, lupus, sarcoidosis). La clínica incluye insuficiencia renal, proteinuria, leucocituria (pueden ser eosinófilos), y la tríada característica de fiebre, rash y eosinofilia (síndrome DRESS). No siempre viene con el DRESS completo. Existe el síndrome óculo-renal idiopático (autoinmune) con nefritis túbulo-intersticial más uveítis. El diagnóstico definitivo es con biopsia renal. El tratamiento incluye suspender el fármaco causante (o tratar la infección/enfermedad autoinmune) más corticoides. Importante: el tratamiento se inicia ante la sola sospecha clínica, antes de la biopsia renal.